Mortalité des enfants de 2 à 59 mois hospitalisés pour une pneumonie sévère et facteurs prédicteurs au Centre Hospitalier Régional de Banfora au Burkina Faso.

Nom du présentateur : KIEBRE Pegd-Wendé Blaise

Auteurs et coauteurs : Pegd-Wendé Blaise KIEBRE[1], Lucien Désiré DAHOUROU[2], Ter Tiero Elias Dah[3] et al.

Affiliations : 1 INSP/CRSN, 2 CNRST/IRSS, 3 UBLO

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

❑ Pneumonie : problème santé publique mondiale

- Dans le monde & Afrique: 1ère cause de décès enfants < 5 ans
- Au Burkina Faso: 3ème cause de mortalité intrahospitalière (2024)

❑ Pneumonie : tendances à la baisse

- Baisse de 30% de l'incidence entre 2000 et 2015
- Baisse 51% mortalité 2000-2019: 1,7M à 740180 décès
- Progrès rendus possibles grâce: PEC améliorée, vaccination (PCV & Hib)

❑ Défi persistant pourtant

- Maitriser la mortalité liée à la pneumonie : axe incontournable pour atteindre l'ODD 3.2
- Mieux comprendre pour mieux agir: **facteurs associés à la mortalité**

Objectifs

❑ Général

Etudier la mortalité intrahospitalière de la pneumonie sévère des enfants de 2 à 59 mois hospitalisés au CHR de Banfora du 30 août 2021 au 31 janvier 2024

❑ Spécifiques

- Estimer la prévalence de la pneumonie sévère
- Estimer le taux de mortalité liée à la PS des enfants de 2 à 59 mois
- Identifier les facteurs prédicteurs de décès chez ces enfants

Matériel et méthode(s)

❑ Type d'étude et période d'étude

Cohorte prospective, analyse secondaire étude PNA, 30-08-2021 au 31-01-2024

❑ Etude PNA

- Surveillance épidémiologique PS en hospitalisation août 2021 - janvier 2024
- Impact changement du calendrier vaccinal de PCV13 de 3p+0 à 2p+1
- Critères d'inclusion: 2-59 mois, résidant au Burkina Faso, pneumonie sévère
- Critères de non inclusion: transféré d'un site de l'étude après 48h d'hospitalisation, symptômes 48h après l'admission au CHR, amendement tachypnée au bronchodilatateur

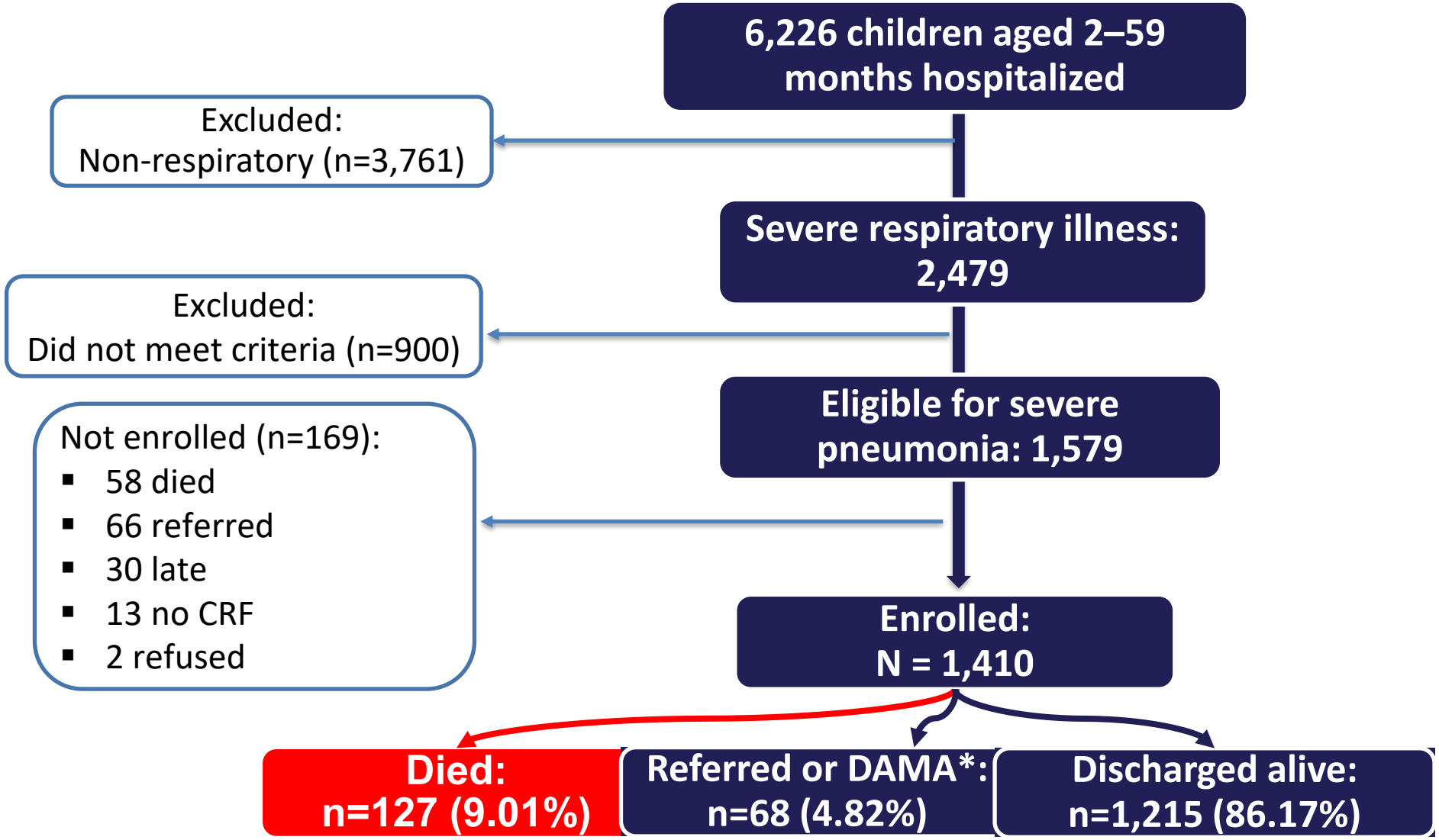
Matériel et méthode(s)

- **Cadre d'étude** : pédiatrie CHR de Banfora
- **Echantillonnage** : Exhaustif
- **Variable dépendante** : mode de sortie (décès, évacué, SSAM)
- **Évènement d'intérêt** : décès
- **Variables indépendantes** : sociodémographiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques

Matériel et méthode(s)

- **Analyse descriptive** : fréquence, pourcentage, moyenne, médiane
- **Analyse de survie** : risques compétitifs de Fine et Grays
- **Paramètres analyse de survie**
  - Date d'origine : admission aux urgences
  - Dernières nouvelles : date de sortie
  - Temps de suivi : admission – sortie
  - Risque compétitif : décès vs évacué
  - Seuil de significativité : 20% à l'univariable et 5% pour la multivariable
- **Aspect éthiques et déontologiques :** CERS, CME,

Résultats



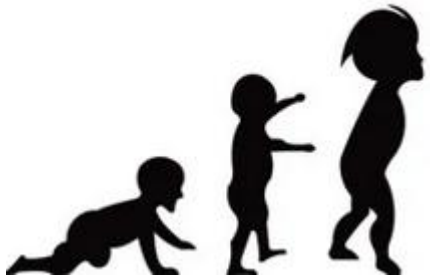
**DAMA: discharged against medical advice*

Caractéristiques des participants

18 mois (intervalle interquartile [IIQ]: 9-32 mois)

53,19% (750/1410) de de garçons

Troubles de la conscience (80,21%, 1131/1410)
vomissements persistants (29,93 % ; 422/1410)

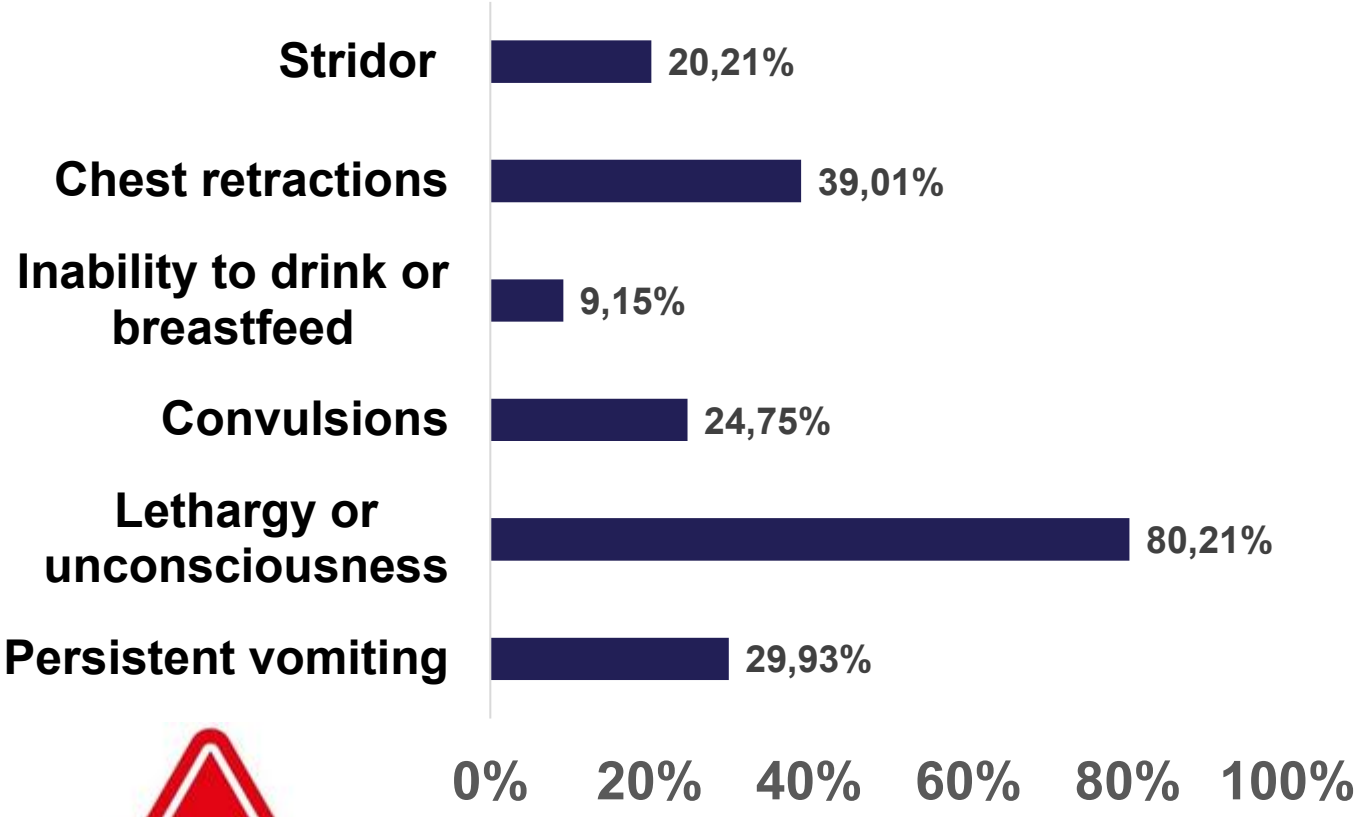


41,42 % (584/1410) âgés de 24–59 mois

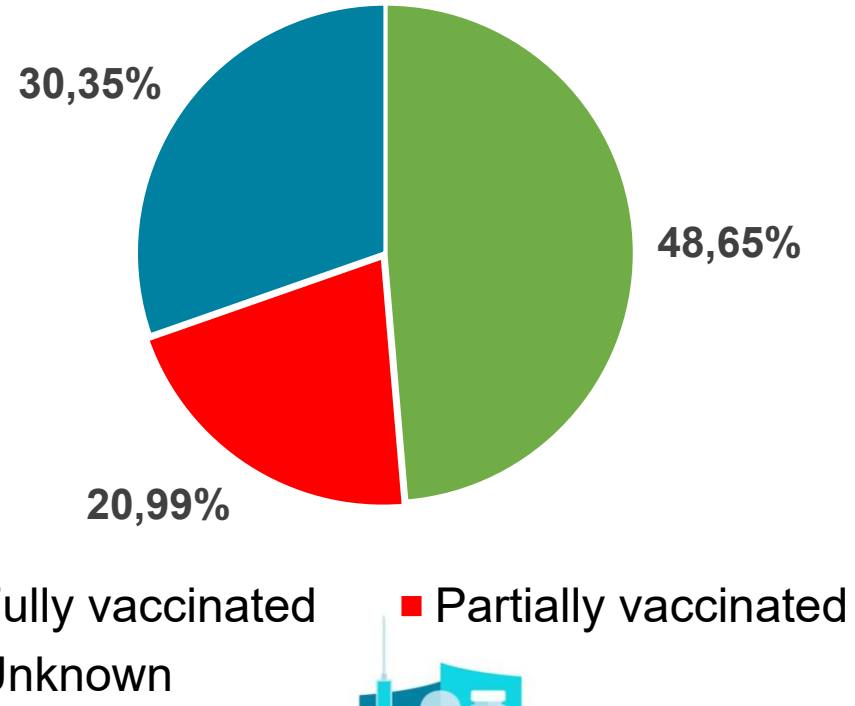
28,71% (404/1407) avec malnutrition aigüe sévère

58,89% (825/1401) coinfectés par le paludisme

Caractéristiques des participants

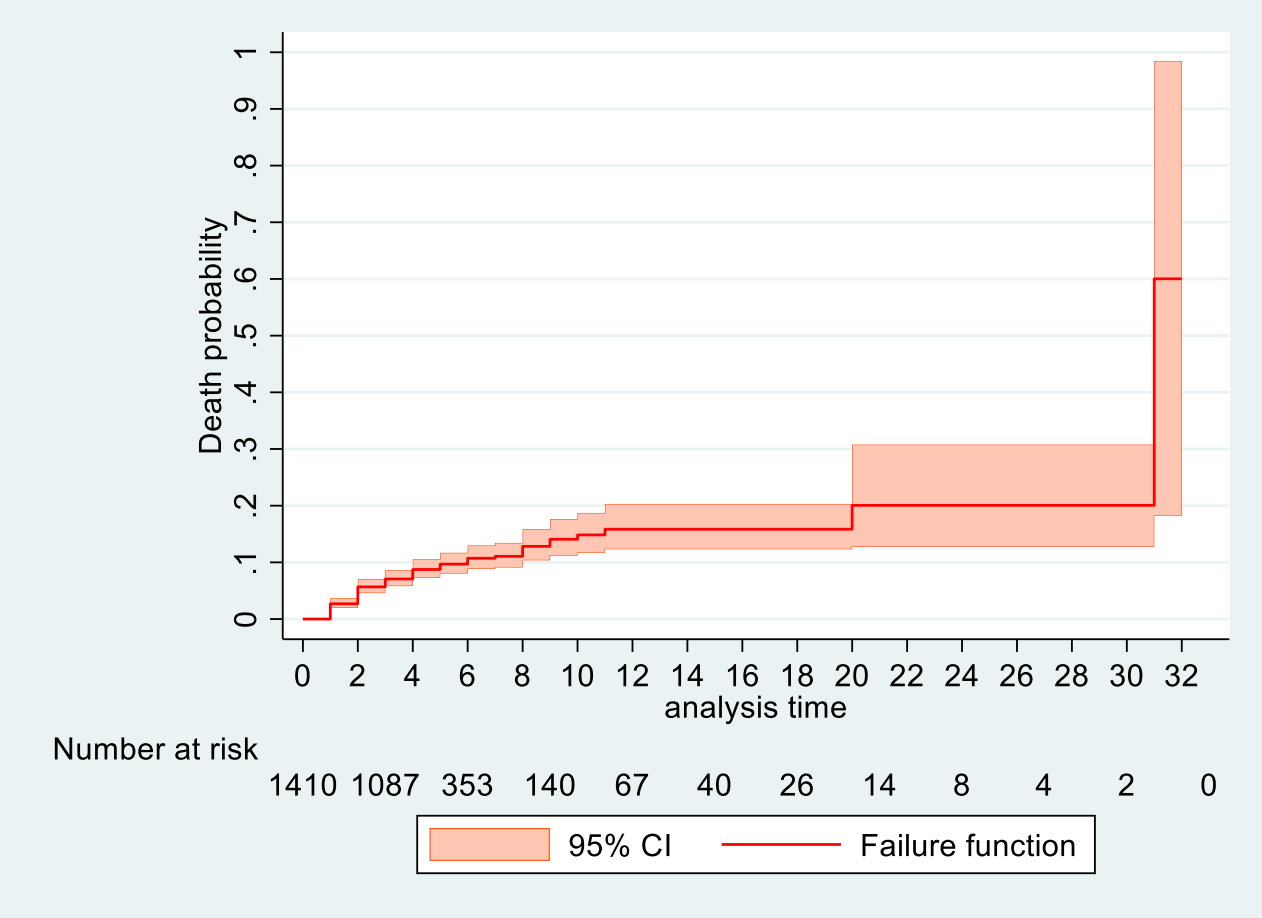


Signes de dangers

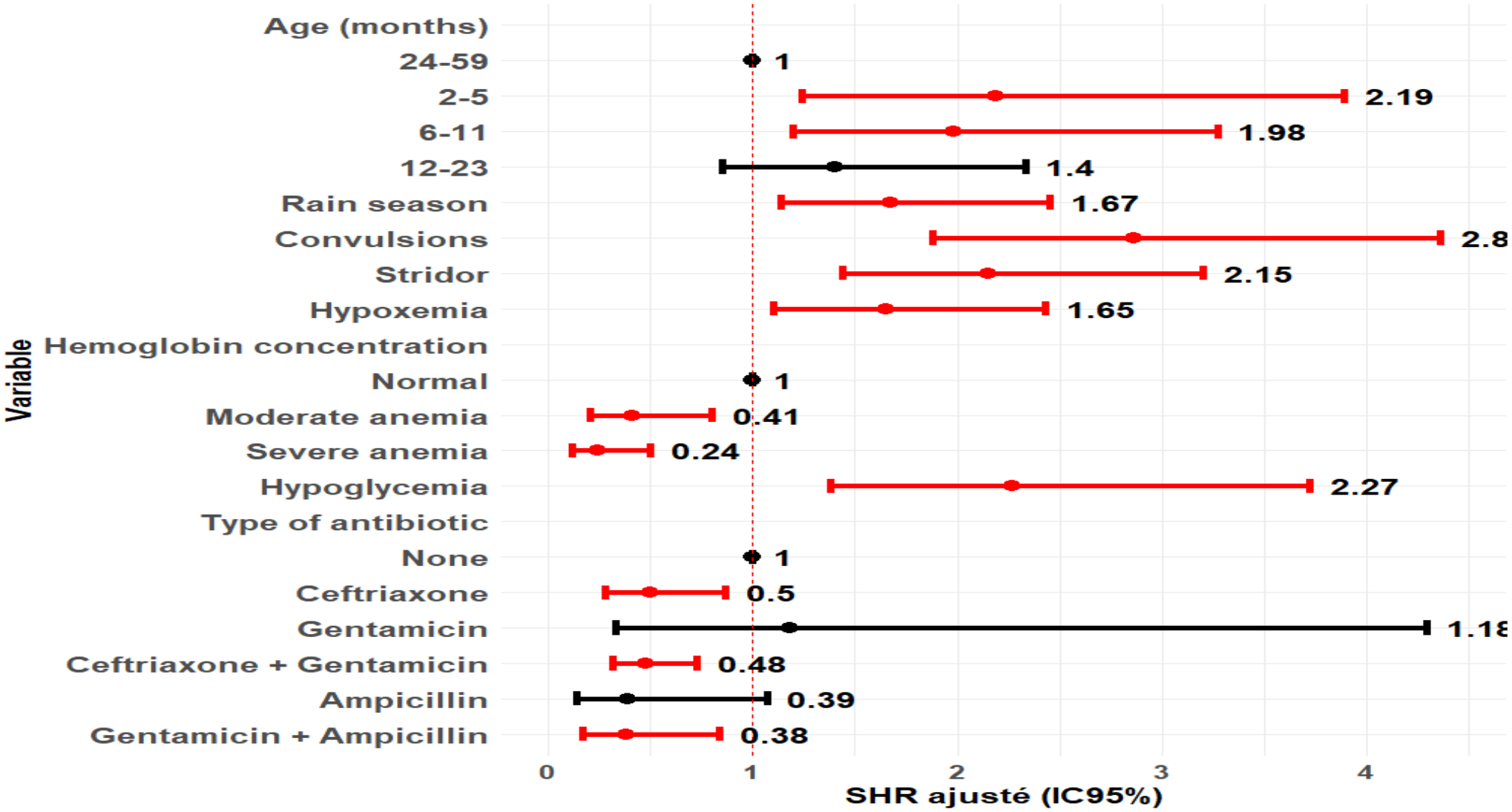


Mortalité

- **Durée totale de suivi** : 1410 participants suivis pendant 6 554 jours
- **Décès** : 127
- **Taux de mortalité** : 1,94 pour 100 personnes-jours (IC 95 % = 1,63 à 2,31)
- **Probabilités de survie** :
  - J1 : 97,3%
  - J3 : 92,93%
  - J7 : 88,93%



Prédicteurs de la mortalité



Conclusion

- Mortalité hospitalière élevée de la pneumonie sévère au CHR de Banfora
- Facteurs de risque de décès : jeune âge, hospitalisation pendant la saison pluvieuse, hypoxémie, convulsions, hypoglycémie, stridor
- Facteur protecteur : antibiothérapie adaptée
- Contrôle possible de certains facteurs prédicteurs
  - Trier et surveiller davantage les malades les plus à risque
  - Appliquer les protocoles de prise en charge
- Interventions ciblées indispensables pour atteindre l'ODD 3.2 en 2030 au Burkina Faso

Merci pour votre attention